



Antônia

Antônia caminhava pela Rua do Quidé e proseava com um e outro que cruzava pelo caminho. Na mão, sempre uma sacolinha de loja com seu rádio, escova, uma bíblia e alguns cacarecos. Nessa manhã ela estava mais alinhada que de costume porque ia ao centro da cidade com Gislene.

De longe, vê Gislene no ponto de ônibus e ouve ela falar com aquele vozeirão: “Ô Antônia, tu trouxeste o documento? Vamos embora que voltar com o sol quente vai me deixar mole”. Antônia ri alto e pergunta se ela tem cara de esquecida: “Louca pode ser, mas esquecida, não!”. E repete isso algumas vezes para uma outra que estava ali de figurante da cena. No radinho que está na sacola, o pastor divulga curso para casais em crise.

Ninguém daquela época se esquece de Antônia. É uma memória feita na base da convivência diária, entre choro, suor e alegria, entre ela e os trabalhadores e outros usuários do CAPS Pirex. Os estagiários e os trabalhadores mais novos sempre se perguntavam por que Antônia continuava indo ao serviço se ela estava tão bem. Uma discussão sempre voltava à roda: “Ela vai ficar vindo só para almoçar?”. O “só para almoçar” era um jeito de dizer que talvez ela já não precisasse mais estar ali, ou que não cabia nos “critérios” de um serviço tão cheio de demandas.

Nessas horas, alguns profissionais mais antigos, com um meio sorriso e um certo ar de quem já viu muita coisa, retrucavam: “Só para almoçar? Então leia o relatório que veio do manicômio judiciário”. Era a forma às vezes irônica, às vezes terna, que os mais experientes encontravam para alertar os desavisados sobre as histórias das pessoas, para além do que se vê no imediato do contato com alguém.

Antônia era egressa do Manicômio Judiciário. No relatório, 30 páginas em que a alcunha “psicopata” era usada sem cerimônias junto a descrições de cenas violentas de suas crises de “hetero e autoagressividade”. Grande parte dos relatos registrados falava de agressões a profissionais de saúde.

Os estagiários de enfermagem, de passagem pelo Pirex e curiosos com aquela figura marcante que cruzava os corredores, ficaram impressionados. Diante deles, formavam-se duas imagens quase irreconciliáveis: a Antônia descrita nos papéis do hospital – perigosa, violenta, imprevisível – e a Antônia que agora circulava pelo CAPS, rindo alto, ajudando na cozinha, brigando e se reconciliando com a mesma intensidade com que vivia.



Gislene, copeira e cozinheira do serviço, uma das referências mais firmes de Antônia, se agita e dispara: “Já que vocês estão bem assim na vida, eu é que não vou convidar mais ninguém para o caruru deste ano, viu? Aff, comida não se nega a ninguém!”. Não sabia ao certo se os meninos perguntavam por curiosidade ou desconfiança, mas, mulher vivida e sensível, aprendeu que com fome não tem discussão. Nunca tinha trabalhado em serviço de saúde antes e, no entanto, fez-se referência. Foi aprendendo no calor do cotidiano, afinando o gesto e a palavra, aprimorando o trabalho a partir da convivência com Antônia, uma relação que já foi bem mais turbulenta do que é hoje.

Quando Antônia chegou pela primeira vez, anos atrás, os profissionais que fizeram o acolhimento ficaram assustados com o calhamaço médico que chegou encaminhado pela instituição judiciária. Gislene estava lá. No entanto, a equipe do recém-inaugurado CAPS II, ansiosa por fazer diferente, empenhou-se em não paralisar pelo medo e decidiu, sob alarde de muitos, reavaliar o diagnóstico, suspender o rótulo e o uso do termo “psicopata”, pelo menos até conhecer melhor quem era Antônia. Gislene uma vez anunciou: uma mulher preta, que veio lá do sul da Bahia, como eu.

Algo havia se iniciado com a chegada de Antônia – um modo de cuidado tateante para conhecer a usuária, em contraste com um modelo bastante ambulatorial, preso a horários e agendas fixas que alguns profissionais tinham como o correto e mais organizado a se fazer, um modelo de atendimento. A aproximação entre equipe, família e usuária acontecia aos poucos, morna, como quem ainda mede a temperatura.

Um tempo depois de estar frequentando o CAPS, Antônia foi convidada para uma excursão, a fim de ver as luzes de Natal no parque. Durante o passeio, perdeu-se do grupo, sumiu no meio da multidão e das árvores. Foram horas de procura até que a encontraram, desorientada, e foi levada ao Hospital Municipal. Ficou quase dois meses na urgência da psiquiatria. Lá, batia nos profissionais, resistia às regras e, mais uma vez, foi reconhecida, ou marcada, por sua agressividade.

Os enfermeiros do Hospital costumeiramente perguntavam aos profissionais do CAPS, em reunião de rede, como Antônia estava e diziam: “Tigrone, hein” – jargão da enfermagem para falar de pacientes que têm força física e psíquica e questionam ou não aceitam as ordens da instituição. Outro funcionário da Urgência disse que a equipe precisava ficar atenta para não dar “asa à cobra”, agora que finalmente viu quem era a “verdadeira Antônia”.

A equipe se dividiu sobre o que fazer depois daquela primeira crise. O medo circulava pelos corredores e crescia no olhar de alguns que diziam que Antônia talvez não fosse “perfil CAPS”,



e que não havia jeito de cuidar daquele “tipo de crise” no serviço, era perigoso e irresponsável. Sonhavam com um serviço especializado, com fronteiras definidas e parâmetros de triagem que dessem finalmente segurança em um dia a dia instável. Esse efeito Bacamarte moderno em que se dita o que é e quem é o outro para se defender do risco e da surpresa.

Por outro lado, outros defendiam que o hospital é mais violento que Antônia e que o lugar dela era em casa, com apoio, com gente por perto. No meio de toda essa discussão interna, muitas vezes, Antônia voltava sua raiva contra as irmãs, que insistiam para que tomasse a medicação. Esse era um ponto sensível, quase ferida aberta. Contava, com voz firme e um misto de dor e revolta, que a mãe havia morrido anos antes por causa dos remédios psiquiátricos e de um tratamento mal feito em sua cidade natal.

Desde então, qualquer conversa sobre remédio vinha carregada de lembrança e desconfiança, como se cada comprimido trouxesse junto um pedaço daquela perda antiga. A discussão chegou quente à supervisão. O supervisor ouviu os relatos e, depois de um breve silêncio, perguntou: “E o que aconteceu com Antônia? Ninguém percebeu que ela estava em dificuldade?”.

Lá do fundo da sala, Gislene se remexeu na cadeira. O olhar do supervisor a alcançou, ela desviou por um instante, como quem sabe que entendeu antes dos outros o que estava se passando. Como quem não quer nada, ainda alfinetou a equipe perguntando como seria realizada a acolhida sem ser CAPS III, 24 horas, ainda mais com o drama familiar instaurado.

O supervisor não era contra tirá-la do hospital. A equipe sabia que ele tinha nas costas anos de experiência com situações de crise em liberdade, em que inventou jeitos e jeitos de acolher, mesmo quando não era muito viável institucionalmente. Puderam escolher o supervisor e foi justamente por causa de sua experiência em Santos que o chamaram. Ele não era contra tirá-la, mas queria preparar a equipe para verdadeiramente acolher uma situação dessas, em toda sua intensidade.

A jovem equipe sonhava em conseguir que a prefeitura transformasse o serviço em 24 horas, porque via que o trabalho intenso e delicado não adiantava muito quando uma crise chegava e não havia um lugar para o usuário ou a usuária passar a noite, conseguir acolhimento fora do ambiente de sua casa. Não conseguiu transformar para 24 horas, mas ampliou o atendimento no dia a dia (de 8 para 12 horas), abriu inclusive aos sábados, inventou jeitos e fluxos com o CAPS III mais próximo e também acompanhamento no domicílio o mais próximo possível.



Enfim, o Hospital não autorizou a saída, nem a família se sentiu segura, mas quando, finalmente, Antônia foi liberada, estava extremamente sedada e, ao mesmo tempo, ainda brigona (mesmo que sem poder de ação). Durante a internação, a equipe se organizou para ir todos os dias na ala psiquiátrica. Isso irritou alguns profissionais da equipe hospitalar, mas fez com que houvesse o mínimo de continuidade no trabalho que fazia no território e que foi interrompido pela internação.

A equipe levava mudas de roupa quando necessário e ainda ajudava no banho e na comida. Organizou-se para levar a família à visita, e isso fez com que houvesse mais confiança das irmãs de Antônia no cuidado do CAPS, o que fez muita diferença na próxima situação enfrentada.

Gislene voltava triste das visitas. Antônia recebia a referência na base do xingamento e dizia que ela não prestava e botava veneno na comida. Mas não era nem por isso que a referência cogitou não ir mais ao hospital. Não aguentava ver a situação de Antônia, amarrada, e também a profissional não era bem tratada pela equipe do hospital, que sabia que ela não era da saúde. O gerente insistiu que ela continuasse e, em reunião de equipe, surgiu a ideia de que a médica fosse junto um dia ou outro, também como forma de emprestar poder.

A ida da médica possibilitou também a discussão da medicação conjuntamente. O hospital teve dificuldade e resistência de coordenar os médicos de plantão com a médica no CAPS, mas a insistência do CAPS gerou frutos importantes para a saída mais rápida da usuária.

Para a tão sonhada saída, o CAPS cria um plano para que Antônia fique mais tempo no serviço e designa que o transporte tenha prioridade para pegá-la todo dia. Negocia uma provável acolhida do CAPS III do outro bairro, único CAPS III da cidade. Para conseguir que o serviço 24h concorde, garante que um técnico do Pirex estará sempre com Antônia. Para isso, precisou convencer a supervisora de saúde do território a deixar o técnico de enfermagem fazer plantão noturno. Ela aceitou!

O cotidiano depois da saída ainda é difícil, Antônia fica irritada, tenta arranjar brigas, questiona os profissionais, fica de olho nos horários de entrada e saída, nas conversas do corredor, e bufa muito. Os profissionais começam a ficar cansados das negociações quase ininterruptas sobre a saída para a rua e sobre as reclamações a respeito da equipe. Antônia se metia em tudo e não poupava críticas.

Em um desses dias, ela vai até a cozinha e xinga Gislene, que servia café para uma outra usuária. O CAPS todo ouve. Antônia costuma ficar indignada com a falta de hierarquia e regras



do serviço, e não admite que o café seja dado para um usuário de novo: “Cada hora é uma regra aqui, pode ou não pode pegar mais café?”. Antônia nem toma café, mas bufou mais uma vez e foi procurar o gerente no ritmo lento que a sedação da medicação permitia. Volta com ele pela mão e busca sua aprovação.

Gislene, por sua vez, ofereceu dois copos de café com bolo para cada um, indicando que se sentassem. Gislene passa, então, a falar que, para ela, Deus era a força da natureza em todas as coisas, e faz um discurso sobre problemas reais e problemas que a gente inventa e que Deus quer que nos concentremos naqueles que são reais. Antônia começou concordando com a parte que ela fala de Deus, apesar de serem de religiões diferentes, adorava falar sobre Deus com Gislene, mas, mesmo assim, não gostou do resto e voltou a bufar.

A referência diz firme: “Sem crise, Antônia, vamos ver como a gente resolve”, e sugere que, se ela estava tão preocupada, podia aparecer pela cozinha logo antes do café da tarde para fazer mais uma garrafa e ficar responsável por garantir que todos possam pegar do café de maneira igual e ninguém ficar sem.